

卡马西平不良反应和药物相互作用的研究进展

陈卫华

(屏边县人民医院 云南 屏边 661200)

摘要:卡马西平为临床中常用的一种抗癫痫药物,对于躁狂抑郁,心律失常,三叉神经痛等也都具有明显效果。卡马西平可以通过抗环一腺苷苷引发体质量增加,低血钠症,脱发与胎儿畸形等,卡马西平如果应用不当的话,是会产生一些不良反应的,比如和去甲肾上腺素、钙离子、抗雌激素等作用都有可能致多种不良反应。一直以来,卡马西平的不良反应与药物的相互作用都是医学专家密切研究的问题,本文就卡马西平的不良反应以及药物的相互作用问题做了相关的介绍和描述,供大家参考。

关键词:卡马西平;不良反应;药物相互作用;研究进展

【中图分类号】R696

【文献标识码】B

【文章编号】1009-6019(2013)03-0068-01

卡马西平也称做是酰胺咪嗪、巴米嗪,属于广谱抗惊厥药的一种,它的化学结构与三环类抗抑郁药物比较相近,对于癫痫精神病的治疗可以起到一定作用。卡马西平的口服吸收比较慢,而且并不规则,主要是经过肝脏代谢成为具有一定药理活性的药物。卡马西平属于酶诱导类药物,可以诱导部分药物使血液浓度降低,进而疗效下降,而且有可能诱发一些自身性代谢,降低治疗效果。卡马西平的临床应用随着医学的发展越来越广泛,与其它药物发生的相互作用机率也越来越高。笔者结合相关文献进行综述,以期获得合理的临床用药。

1 卡马西平和抗精神病类药物相互作用

1.1 与氯丙嗪:有学者曾经对氯氮平或氯丙嗪与卡马西平联合方法对精神运动兴奋的治疗效果进行研究,研究结果发现联合采取卡马西平进行治疗的病人,睡眠时间显著延长,而且兴奋的症状得到了明显控制,且近期疗效明显好于单用组^[1]。单用效果如果不明显的话,联合用药是一种比较好的治疗方法。但是,卡马西平是细胞色素 P450 的酶诱导剂,这两者联合使用能够使氯丙嗪血药浓度降低,停用之后氯丙嗪的血药浓度能够恢复至正常水平。

1.2 与氯氮平:氯氮平能够显著增加抽搐的发生率,大约 11% 的服药患者会出现阵挛或大发作,而且和药物的剂量密切相关。卡马西平能够使抽搐危险明显降低,但是这两者不适宜联合应用,因为氯氮平有可能影响到造血系统、抑制骨髓造血功能;卡马西平对于造血系统会有毒性,这两种药物联合应用必定会对造血系统产生一定毒性作用,使并使粒细胞缺乏的危险性增加。

1.3 奎硫平与齐拉西酮:卡马西平还可以增加齐拉西酮与奎硫平的代谢,有可能是由于对 CYP3A4 诱导作用导致的。在精神病人的药代动力学研究当中,卡马西平的剂量是 200g·# 13198,每天 3 次,能够使得奎硫平最大的血药浓度减少量为 80%,且清除率明显增加。

2 不良反应

2.1 抗环一磷酸腺苷效应

2.1.1 低钠血症:甲状腺激素如果经环一磷酸腺苷能够促进甲状腺素的释放,卡马西平能够对环一磷酸腺苷起到一定抑制作用,使甲状腺素的水平下降,但是不能够使甲状腺机能发生减退,抗利尿素则可以通过对环一磷酸腺苷的激动作用促使肾小管对钠的重吸收,卡马西平对环一磷酸腺苷进行抑制,所以能够抑制肾小管对钠的重吸收,引起了低钠血症的发生^[2]。

当患者体内卡马西平的血浆浓度比较高或者卡马西平与奥卡西平联合使用再利尿的时候,或者老年病人都极易出现临床低钠血症。

2.1.2 体质量增加:β3 受体经过激动环一磷酸腺苷分解,而卡马西平能够对环一磷酸腺苷起到抑制作用,所以可以对脂肪分解起到抑制作用,使体质量增加,但是程度比不上磷酸锂和丙戊酸钠。

2.1.3 畸形:卡马西平能够对环一磷酸腺苷起到抑制作用,进而会抑制胎儿的发育^[3],卡马西平诱导 CYP3A4 酶,能够抑制叶酸、维生素 K、维生素 D 以及甲状腺素等的形成,从而对胎儿发育起到一定的抑制作用,使发育延迟。在妊娠的前 3 个月服用卡马西平,有可能导致小儿脊柱裂的发生,其它还有可能发生心脏畸形、小头畸形、唇/腭缺陷等,胎儿畸形率是非常高的。

2.2 抑制造血

2.2.1 种类:卡马西平能够使全血细胞降低,其中 10% 的患者会引起一过性的白细胞数量下降。研究发现约五分之一患者会发生再生障碍性贫血,有可能导致死亡。

2.2.2 检查:在治疗前应当进行血常规检查,在治疗后的 2 周对血常规进行复查,之后每半年进行 1 次复查。如果治疗过程当中出现发热、皮疹、喉痛和口腔溃疡,应当及时进行复查。

2.2.3 处理:如果白细胞数量下降到 $3.0 \times 10^9/L$,血细胞比容 $< 32\%$,血小板 $< 100 \times 10^9/L$,网状细胞 $< 0.3\%$ 时,则应当立即停止服用药物,并发生感染的患者应当进行相应的临床治疗。

3 与抗感染类药物联合应用

大环内酯类属于药酶抑制类药物,与卡马西平联合应用,能够抑制卡马西平代谢,使卡马西平的血浓度上升,容易出现多种不良反应。多红霉素基本上不会对卡马西平产生影响,头孢唑林钠会使卡马西平的血浓度显著上升,在联合应用时一定要监测卡马西平的血浓度以防止中毒。与强力霉素联合使用时,则可以降低其血药的浓度,在必要时需对剂量进行调整;酮康唑、氟康唑为 CYP3A4 抑制药,能够使卡马西平的血浓度上升,异烟肼可以抑制卡马西平代谢,使卡马西平的血药浓度上升,进而引起多种不良反应;同时卡马西平可以诱使烟肼微粒体代谢,会使具有一定肝毒性的代谢物增加,这一点应当引起相关人员的注意。

4 与抗抑郁类药物合用

4.1 氟酰胺苯胺:曾经有报道对于单纯采取氟酰胺苯胺药物治疗没有效果的抑郁症病人合用卡马西平进行治疗,取得了相应疗效,但是由于卡马西平的酶诱导作用有可能致使氟酰胺苯胺血药浓度下降而影响到疗效。

4.2 米氮平:米氮平是主要经 CYP2D6、CYP1A2、CYP3A4 进行代谢^[4]。研究发现,卡马西平能够使米氮平的 C_{max} 和 AUC 减少,但是却使去米氮平的 C_{max} 增加。米氮平并不会改变单剂量的卡马西平的酶诱导或药理学作用,对于卡马西平药理学参数并没有产生影响,但是可以降低 CBZ-EP 的浓度,提示两种药物联合应用是比较安全的,但是需要使米氮平的剂量增加来保持抗抑郁效果。

4.3 与锂盐联合应用:卡马西平同锂盐联合应用具有一定的协同作用,在治疗躁狂症时的作用明显优于单独的药物,但是也会增加毒性,目前两种药物的协同作用原理尚未清楚。

5 结论

概括起来说,卡马西平和一些使我联合应用时会产生作用影响到血药浓度与疗效。当需要和其它药物联合应用时,一定要注意相互作用发生不良反应的可能性,仔细进行观察,以免出现药物不良反应。不管是单用还是联合用药,都应当及时监测卡马西平浓度,对治疗方案进行治疗调整,保证临床用药的合理性^[5]。

参考文献

- [1] 喻东山. 卡马西平不良反应和药物相互作用的研究进展[J]. 医药导报, 2010, 29(10): 1281-1284
- [2] 耿黄宁. 卡马西平在临床应用中的进展[J]. 江苏药学与临床研究, 2006, 14(4): 232-235
- [3] 尹宗莹. 卡马西平的药物相互作用[J]. 临床精神医学杂志, 2008, 18(3): 208-209
- [4] 任文艳. 卡马西平临床合并用药及不良反应[J]. 中国实用医药, 2010, 05(36): 177-178
- [5] 石红伟. 卡马西平临床合并用药及不良反应[J]. 医药前沿, 2012, (21)